

유방암 진단 첫 30일

아형 · 수술 · 전신치료 순서 이해

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 01

MINI 무료 배포판 · Instagram 구독자용 · 2026년 10월 개정 2판

유방암은 하나의 병이 아닙니다. 호르몬수용체와 HER2가 치료 순서를 바꿉니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Breast Cancer, Version 7.2026(환자용 해설 2.2026-0기 1.2026 대조) 외 국내 자료(본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 MINI판에 대하여

이 MINI판은 진단 후 첫 30일 동안 **안전하게 판단하는 데 꼭 필요한 내용만** 담았습니다. 응급 신호, 진단 직후 할 일, 병리·병기의 핵심, 치료 흐름, 진료실 질문, 한 장 요약은 완전판과 같습니다. 30일 일자별 실행 로드맵, 치료별 준비·회복 가이드, 한국 제도·보험 서류 안내, 마음 돌보기와 보호자 가이드, 워크북은 완전판에 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 0기와 침윤암, 그리고 아형

30초 요약

- **0기(관상피내암, DCIS)**는 암세포가 젖관 안에 머문 **비침윤성** 암입니다. 침윤암과 치료 범위가 다릅니다(4장).
- **침윤성 유방암**은 아형이 치료 순서를 정합니다: **호르몬수용체(ER·PR) · HER2 · 등급/Ki-67 · 병기**.
- 같은 "2기"라도 아형에 따라 **수술 먼저** 또는 **약물치료 먼저**가 될 수 있습니다.

결과지에 적힌 말	뜻	볼 곳
DCIS, 관상피내암, 유방 상피내암	0기, 비침윤성	4장
LCIS, 소엽상피내종양	대개 암이 아니라 위험 표지 . 치료가 아니라 추적·위험 관리	담당의 확인
침윤성 유관암(IDC, NST)	가장 흔한 침윤성 유방암	이 책 전체
침윤성 소엽암(ILC)	두 번째로 흔함. 영상에서 범위가 작게 보일 수 있어 MRI를 더하기도 함	5장

아형 4가지 한눈에 보기

아형	검사 결과	치료의 큰 축
HR+/HER2- (가장 흔함)	ER 또는 PR 양성, HER2 음성	수술 → (필요 시 항암) → 내분비요법 5~10년

아형	검사 결과	치료의 큰 축
HER2 양성(유방암의 약 15~20%)	HER2 3+ 또는 2+·ISH 양성	항암 + HER2 표적치료. 종양이 크거나 림프절 양성이면 수술 전 치료
삼중음성	ER·PR·HER2 모두 음성	항암 중심, 2기 이상은 수술 전 항암 (+면역치료 범주)
HR+/HER2+ (삼중양성)	둘 다 양성	HER2 표적치료 + 내분비요법

첫 30일의 지도

순서	할 일	시기
①	조직검사 결과(침윤 여부·아형) 확인	Day 0-3
②	유방 영상(촬영·초음파·필요 시 MRI)·병기 검사	Day 3-14
③	유전자검사 대상 여부, 가임력 희망 알리기	첫 진료
④	수술 먼저 vs 수술 전 약물치료 결정	Day 10-21
⑤	수술 방법(보존·전절제·재건) 또는 항암 준비	Day 14-30

오늘 물어볼 질문

1. 제 암은 0기인가요, 침윤암인가요?
2. 호르몬수용체와 HER2 결과는 어떻게 나왔나요?
3. 저는 수술을 먼저 하나요, 약물치료를 먼저 하나요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자 — 다음 예약까지 기다리지 말고 바로 연락하거나 응급실로

- 항암치료 중 **38°C 이상 발열**이나 오한 → **해열제로 열을 내리기 전에 먼저 병원에 연락**
- 수술 부위가 갑자기 크게 붓고 단단해짐, 고름·악취, 배액관 주위 심한 발적
- 수술한 쪽 팔이 **빨강고 뜨겁게 붓고 열이 남**(봉와직염 가능성)
- 갑작스러운 흉통·숨참, 한쪽 다리 부종(혈전 가능성)
- 항암·표적 주사 중이나 직후 두드러기·얼굴 부종·숨참(과민반응)
- 하루 4~6회 이상 설사·탈수, 물을 마시지 못하는 구토
- 면역치료 중 심한 피로·어지럼, 숨참, 심한 설사·혈변, 눈·피부 노래짐
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ **109**(24시간), 119

본문 목록으로 한 번 더 적습니다.

1. 항암 중 발열은 백혈구 감소에 따른 감염일 수 있어 빠른 평가가 필요합니다.
2. 수술 부위 혈종·감염은 늦게 발견할수록 회복이 길어집니다.
3. 팔의 열감·발적·부종은 림프부종에 생긴 감염일 수 있습니다.
4. 흉통·숨참·한쪽 다리 부종은 혈전·폐색전 가능성이 있습니다.
5. 심한 설사(일부 표적치료제·항암제), 탈수는 신장 기능을 떨어뜨릴 수 있습니다.
6. 면역치료 부작용은 몇 달 뒤에도 생길 수 있습니다.

첫 치료 전에 할 일: 평일 진료실, 야간·휴일 연락처, 가까운 응급실을 내 휴대폰과 보호자 휴대폰에 저장하세요.

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 세 가지만. ① 조직검사 결과지 받기 ② 유방 전문의 진료 예약 ③ 복용 중인 피임약·여성호르몬제와 임신 계획 정리.

오늘 할 일 (3개)

- ☐ 조직검사 결과지 사본 받기 — 침윤 여부, ER·PR·HER2, Ki-67
- 국내에서는 굵은 바늘 조직검사(총생검)나 진공흡인생검(흔히 '맘모툼')으로 진단하는 경우가 많습니다. 맘모툼으로 보이던 병변이 거의 다 빠졌더라도 암이면 수술 등 치료가 따로 필요합니다. 위치 표시 클립을 넣었는지 확인해 두세요.
- ☐ 유방외과(유방암 수술 전문) 진료 예약
- ☐ **피임약·여성호르몬제**를 먹고 있다면 기록 — 첫 진료에서 바로 알립니다. 임신 가능성이 있으면 검사 전에 말합니다.

이번 주 할 일

- ☐ 영상검사 일정 확인(유방촬영·초음파, 필요 시 유방 MRI, 병기에 따라 CT·뼈스캔·PET/CT)
- ☐ 가족력(유방암·난소암·췌장암·전립선암, 남성 유방암) 정리 → **유전자검사 대상** 여부 묻기
- ☐ 앞으로 임신을 원하면 **가임력 상담 의뢰**를 첫 진료에서 요청
- ☐ 산정특례 신청 여부 원무과 확인(확진일로부터 30일 이내 신청 시 확진일부터 적용, 상피내암 적용 여부 확인)
- ☐ 2차 소견·전원 예정이면 슬라이드·영상 CD 대여 방법 확인

보호자 몫

- ☐ 진료 동행·기록 ☐ 일정 정리 ☐ "왜 검진을 안 받았어" 같은 말 대신 "같이 준비하자"

마음 점검 한 줄

지금 마음의 고통은 0~10 중 ____점. 4점 이상이면 첫 진료에서 그대로 말해도 됩니다. 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 ☎ 109(24시간).

오늘 물어볼 질문

- 1. 제 조직검사 결과에서 아형은 무엇인가요?
- 2. 병기를 정하려면 어떤 검사가 필요한가요?
- 3. 유전자검사와 가임력 상담 대상인가요?

4장. 0기(관상피내암, DCIS)라고 들었다면

30초 요약

- 0기는 암세포가 젖관 밖으로 나가지 않은 **비침윤성** 암입니다. 치료의 목표는 **침윤암으로 진행하거나 다시 생기는 것을 막는 것**이며, 치료 성적이 좋은 편입니다(개인 예후는 담당 의료진 확인).
- 치료는 **수술이 중심**: 유방보존술(± 방사선) 또는 전절제술.
- 호르몬수용체 양성이면 **내분비요법(보통 5년)**이 선택지입니다.

선택지	내용	생각할 점
유방보존술 + 방사선	병변을 깨끗한 절제면과 함께 떼고 방사선	가장 흔한 조합
유방보존술 단독	위험이 낮은 일부(작은 병변·저등급·넓은 절제면·고령 등)에서 방사선 생략을 논의	대상 기준은 담당 의료진 확인
전절제술(± 재건)	범위가 넓거나 여러 곳일 때	감시림프절생검을 함께 하는 경우가 많음

- **감시림프절생검**은 0기에서 보통 필요하지 않지만, **전절제술**을 하거나 침윤암이 의심되면 함께 합니다(전절제 후에는 나중에 하기 어렵기 때문).

- 수술 후 최종 병리에서 **약 10명 중 1명꼴로 침윤암이 함께 발견**될 수 있습니다. 그러면 이 책의 침윤암 장으로 넘어갑니다. "오진"이 아니라 정보가 더해진 결과입니다.
- 절제면에 병변이 남으면 재절제를 권할 수 있습니다.

 **완전판에서 이어집니다** — 0기 결정 질문지(방사선 생략·호르몬약 5년), 0기 보험 청구 주의

5장. 병리보고서와 검사 읽기

30초 요약: 먼저 볼 것은 **침윤 여부 · 조직형 · 등급 · ER/PR(%) · HER2 · Ki-67** 여섯 가지입니다.

HER2 판정 3단계 (가장 많이 헷갈리는 부분)

검사 결과	판정	의미
IHC 3+, 또는 2+ 이면서 ISH 양성	HER2 양성	HER2 표적치료 대상
IHC 1+, 또는 2+ 이면서 ISH 음성	HER2 저발현 — HER2 양성이 아님	주로 전이·재발 때 일부 치료 선택에 의미
IHC 0	HER2 음성	—

IHC 2+는 "경계"라서 ISH(FISH·SISH·DISH 등) 추가검사로 확정합니다.
결과가 나오기 전까지는 HER2 상태를 ⏳로 두세요.

항목	보고서 표현	의미
ER / PR	positive 90%, Allred 8	내분비요법 효과 예측. ER 1~10% 저발현 양성 은 의미를 따로 물어보세요
등급	Grade 1·2·3 (Nottingham)	높을수록 빨리 자라는 경향
Ki-67	30%	세포 증식 정도. 기관마다 해석 기준이 다름
LVI	lymphovascular invasion	림프관·혈관 침범
절제면	margin	수술 후 재절제 필요성

 **완전판에서 이어집니다** — 가상 병리보고서 해설, 영상검사별 목적과 흔한 오해

검사 결과 기록

침윤	조직 형	등 급	E R	P R	HER2	Ki- 67	림프절(영상/ 조직)
☐ 0기 ☐			%	%	☐ 양성 ☐ 저발현 ☐ 0	%	
침윤					☐ 		

6장. 병기와 유전자검사

30초 요약

- 병기에는 종양 크기(T)·림프절(N)·전이(M)만으로 정하는 **해부학적 병기**와, 여기에 **아형·등급**을 더한 **예후 병기**가 있습니다. 설명이나 결과지마다 숫자가 다를 수 있으니 어느 쪽인지 확인하세요. 수술 전(임상 병기)과 수술 후(병리 병기) 두 번 정해질 수 있습니다.
- **배선(유전) 유전자검사(BRCA1·2 등)**는 대상이 넓어졌습니다. 결과가 수술 범위와 **수술 후 약 선택**에도 쓰일 수 있습니다.

병기	쉬운 뜻
0기	비침윤성(DCIS)
1기	작은 침윤암, 림프절 전이 없거나 미세
2기	종양이 크거나 겨드랑이 림프절 몇 개
3기	림프절 다수·피부/흉벽 침범·염증성 유방암
4기	뼈·폐·간·뇌 등 원격전이

유전자검사 대상이 될 수 있는 경우(예시, 기준은 의료진 확인)

- 비교적 젊은 나이의 진단, 삼중음성, 남성 유방암, 양측 유방암
- 가족 중 유방암·난소암·췌장암·전립선암(고위험)
- 재발 위험이 높아 PARP 억제제 보조요법을 고려하는 경우 결과가 나오면 **가족 상담(유전상담)**과 연결됩니다.

오늘 물어볼 질문

1. 제 임상 병기는 무엇인가요?
2. 유전자검사 대상인가요? 결과가 치료를 바꾸나요?

3. 전이 검사는 제게 필요한가요?

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

7장. 치료 경로 지도: 수술 먼저 vs 약물치료 먼저

30초 요약

- **수술 먼저:** 대부분의 HR+/HER2- 초기암, 작은 HER2 양성·삼중음성.
- **수술 전 약물치료(선행치료) 먼저:** HER2 양성·삼중음성으로 종양이 크거나(대략 2cm 이상) 림프절 양성, 3기, 보존술을 위해 종양을 줄이고 싶을 때.
- 선행치료 후 **남은 암(잔존암)**이 있으면 수술 후 약이 바뀔 수 있습니다.

아형	흔한 순서(범주, 국내 허가·급여 확인 필요)
HR+/HER2- 저위험	수술 → 방사선(보존술 시) → 내분비요법
HR+/HER2- 고위험	수술 → (21유전자 검사 등으로 판단해) 항암 → 방사선 → 내분비요법 + CDK4/6 억제제 보조요법(2~3년) 범주. 배선 BRCA 변이면 PARP 억제제 보조요법 범주
HER2 양성 2기 이상	항암 + HER2 표적치료(이중 표적 포함) → 수술 → 남은 암 없으면 HER2 표적 지속 / 남은 암 있으면 HER2 항체-약물접합체(ADC)로 전환
삼중음성 2기 이상	항암 + 면역치료 → 수술 → 면역치료 지속 / 남은 암 있으면 경구 항암제 또는(배선 BRCA 변이) PARP 억제제 범주
작은(1기) HER2 양성· 삼중음성	수술 먼저 → 병리에 따라 약물치료

수술 전 약물치료를 시작하기 전에 확인할 것

- ☐ 종양에 클립(표지자)을 넣었나요? — 종양이 사라져도 수술 위치를 찾기 위해 필요
- ☐ 겨드랑이 림프절 평가(필요 시 조직검사·클립)
- ☐ 기준 영상 촬영
- ☐ HER2 표적치료 예정이면 **심장 기능 검사**
- ☐ 가임력 상담·난소 보호 주사 논의, 치과 점검, 항암 주사용 포트 여부

21유전자 검사

HR+/HER2-, 림프절 음성 또는 일부 양성 초기암에서 **항암을 더했을 때 이득이 있는지**를 예측하는 검증된 검사입니다(대표 예: 온코타입DX). 결과(재발점수)와 나이·폐경 여부를 함께 봅니다. 국내 비용·급여는 확인이 필요합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 아형별 시나리오 4가지(가상 사례), 항암 시작 전 14일 체크표

오늘 물어볼 질문

1. 제 아형과 병기에서는 수술과 약물치료 중 무엇을 먼저 하나요?
2. 21유전자 검사나 유전자검사 결과가 치료를 바꿀 수 있나요?
3. 수술 전 치료를 한다면 클립·심장 검사는 언제 하나요?

8장. 수술: 보존술·전절제술·겨드랑이·재건

30초 요약

- **유방보존술 + 방사선**과 **전절제술**은 적합한 환자에서 생존율이 비슷합니다. 선택은 종양 크기·위치·유방 크기, 유전자 결과, 본인의 선호로 정합니다.
- 겨드랑이는 대부분 **감시림프절생검**으로 시작합니다. 전이가 있어도 조건에 따라 **겨드랑이 전체 절제를 피할 수 있는** 경우가 늘었습니다.
- 재건은 **수술 전에** 상의합니다(즉시·자연·평평한 봉합).

비교	유방보존술	전절제술
남는 것	대부분의 유방	유방 없음(재건 또는 평평한 봉합)
방사선	대개 필요	병기에 따라
재수술 가능성	절제면 양성 시 재절제	낮음
회복	비교적 빠름	재건 방법에 따라 길어짐

- 작은 HR+/HER2- 1기 종양이고 수술 전 겨드랑이 초음파에서 림프절 이상이 없는 일부(주로 폐경 후)에서는 **감시림프절생검을 생략하는 선택**을, 70세 안팎 이상 고령·저위험 일부에서는 **방사선을 생략하는 선택**을 논의할 수 있습니다 (대상 기준은 담당 의료진 확인).
- 재건: 보형물·자가조직(복부·등 등)·혼합. 흡연은 재건 합병증을 크게 늘립니다.

 **완전판에서 이어집니다** — 수술 전후 체크리스트, 배액관 관리, 어깨 운동 시작 시점, 재건 비교

수술 기록: 수술명 _ **겨드랑이** ☐ **감시림프절** ☐ **겨드랑이 절제** · **재건** ☐ **즉시** ☐ **자연** ☐ **안 함** · **최종 병리 날짜** _

오늘 물어볼 질문

- 1. 저는 보존술과 전절제술 중 어느 것이 가능한가요?
- 2. 거드랑이 수술 범위는 어떻게 정하나요?
- 3. 재건은 언제, 어떤 방법이 가능한가요?

9장. 약물치료: 항암·HER2 표적·내분비·새 보조요법

30초 요약: 약물치료는 아형에 맞춰 조합합니다. 아래는 **범주**이며, 대표 약제는 예시일 뿐입니다(국내 허가·급여 확인 필요).

범주	누구에게	대표 예시	기억할 부작용
항암화학 요법	고위험, HER2 양성, 삼중음성	안트라사이클린·탁산 계열	탈모, 구토, 백혈구 감소 (발열 주의), 손발 저림
HER2 표적치료	HER2 양성	트라스투주맙, 퍼투주맙, HER2 ADC	심장 기능 저하(정기 검사)
내분비요 법	HR 양성	타목시펜, 아로마타제 억제제, 폐경 전 난소기능억제 병용	안면홍조, 관절통, 골밀도 감소, (타목시펜) 혈전· 자궁내막 변화
CDK4/6 억제제 (보조)	고위험 HR+/HER2-	아베마시클립(2년), 리보시클립(3년)	설사·백혈구 감소·간수치, 일부 심전도
PARP 억제제 (보조)	배선 BRCA 변이 고위험 HER2-	올라파립(1년)	빈혈, 피로, 메스꺼움
면역치료	2~3기 삼중음성 (선행치료)	팸브롤리주맙	갑상선·피부·장·폐 등 면역 부작용 — 몇 달 뒤에도 가능

- **내분비요법 기간:** 보통 5년, 재발 위험에 따라 7.5~10년까지 논의. 빠뜨리지 않고 먹는 것이 효과의 핵심입니다.
- 아로마타제 억제제를 먹는다면 **골밀도 검사**와 뼈 보호 방법을 함께 상의하고, 뼈 보호 주사 전에는 치과 점검을 합니다.
- 치료 중 임신은 피합니다. 피임은 **비호르몬 방법**(구리 루프, 콘돔 등)을 의료진과 상의하세요.

■ 완전판에서 이어집니다 — 항암 주기별 부작용 달력, 탈모·두피냉각, 내분비요법 5~10년 생활 가이드

오늘 물어볼 질문

1. 제 아형에 맞는 약물치료 조합과 기간은 어떻게 되나요?
2. 저는 CDK4/6 억제제·PARP 억제제·면역치료 같은 보조요법 대상인가요?
3. 치료 중 피임과 가임력 보존은 어떻게 하나요?

10장. 방사선치료

30초 요약: 유방보존술 후 대부분 방사선을 받습니다. 요즘은 **3주(15회)** **안팎의 짧은 일정**이 흔하고(국내 안내 자료에는 4~6주로 적힌 곳도 있어 병원마다 일정이 다를 수 있습니다), 일부는 1주(5회) 일정이나 부분 유방 조사도 가능합니다. 고령·저위험 일부에서는 생략을 논의합니다.

종류	내용
전유방 조사	유방 전체. 필요 시 종양 자리에 추가 조사(부스트)
부분 유방 조사	종양 주변만. 선택된 저위험군
전절제 후 흉벽 조사	림프절 양성·큰 종양 등
림프절 부위 조사	겨드랑이·쇄골 위·흉골 옆 림프절

- 흔한 부작용: 피부 붉어짐·가려움, 피로. 치료 중반 이후 심해졌다가 끝나고 몇 주 안에 좋아집니다.
- 왼쪽 유방이면 **심장 보호 방법**(숨 참고 조사 등)을 물어보세요.

■ **완전판에서 이어집니다** — 방사선 상담 질문지와 피부 관리

11장. 전이성(4기) 유방암으로 진단받았다면

30초 요약

- 전이 부위 **조직검사로 아형을 다시 확인**합니다(처음과 달라질 수 있음).
- 치료는 아형에 따라 내분비요법 + 표적치료, HER2 표적치료, 항암·ADC·면역치료 등을 조합하며, 많은 사람이 **오랜 기간 치료를 이어 갑니다**.
- 추가 검사(PIK3CA·ESR1 등 유전자, 배선 BRCA, HER2 저발현, PD-L1)가 다음 치료 선택에 쓰입니다.

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

■ 완전판에서 이어집니다

- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법

PART 3. 30일 실행 로드맵

■ **완전판에서 이어집니다** — 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

림프부종·어깨·신체상

30초 요약: 겨드랑이 수술·방사선 뒤 팔이 붓거나 묵직하면 일찍 알려주세요. 일찍 관리할수록 좋습니다. 유방의 변화와 탈모로 인한 신체상 고민은 흔하며, 말해도 되는 주제입니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 림프부종 자가 체크표(팔 둘레 기록), 운동·압박 슬리브, 신체상·관계

추적

항목	일반적 예시(개인별로 다름)
진찰	5년간 1년에 1~4회, 이후 매년
유방촬영	매년(전절제·재건한 쪽은 제외)
골밀도	아로마타제 억제제·조기폐경 시
부인과 진찰	나이에 따라. 타목시펜 복용 중 질 출혈은 바로 알리기. 증상이 없을 때 정기 자궁내막 초음파는 국제 지침에서 일상적으로 권하지 않지만, 국내에는 권하는 병원도 있으니 확인

- 증상이 없을 때 정기적인
CT·뼈스캔·종양표지자
검사는 대개 권하지
않습니다.

항목

일반적 예시(개인별로 다름)

- 알릴 증상: 새 덩어리,
지속되는 뼈 통증, 걸을 때
숨참, 지속 두통, 질 출혈
(타목시펜).

■ **완전판에서 이어집니다** — 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

■ **완전판에서 이어집니다**

- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
3. **제도는 바뀔니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 3개만 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다.

- 1. 제 암은 0기인가요, 침윤암인가요?
- 2. ER·PR·HER2(저발현 포함)·Ki-67 결과는 무엇인가요?
- 3. 임상 병기와 림프절 상태는 어떤가요?
- 4. 수술을 먼저 하나요, 약물치료를 먼저 하나요?
- 5. 보존술·전절제·재건 중 무엇이 가능한가요?
- 6. 21유전자 검사·배선 유전자검사가 필요한가요?
- 7. 보조요법(CDK4/6·PARP·면역치료) 대상인가요?
- 8. 방사선은 몇 주, 어떤 방식인가요?
- 9. 가임력 보존과 피임은 어떻게 하나요?
- 10. 치료 중 바로 연락해야 할 증상은 무엇인가요?

내 유방암 한 장 요약

항목	내 기록
진단	0기(DCIS) / 침윤암(조직형 ____)
아형	HR+/HER2- · HER2 양성 · 삼중음성 · HR+/HER2+
ER / PR / HER2 / Ki-67	% / % / _ / %
병기	임상 _ → 병리 _ ( / )
림프절	_____

항목	내 기록
유전자검사	배선 _ · 21유전자 점수 _
첫 치료	수술 / 선행 약물치료 / 기타
수술	보존술 / 전절제 / 재건 _____
가임력	해당 없음 / 상담 예정 / 완료
산정특례	☐ 신청 ☐ 완료

오늘 꼭 물을 3가지: ① 제 아형과 병기는? ② 수술이 먼저인가요, 약물치료가 먼저인가요? ③ 유전자검사·가임력 상담을 지금 시작해야 하나요?

■ 완전판에서 이어집니다

- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)
- 유방암 용어사전
- 유방암 자주 묻는 질문 13
- 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
- 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크 달력

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Breast Cancer, Version 7.2026(환자용 해설 2.2026·0기 1.2026 대조). NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 유방암 정보, 한국유방암학회 자료, 국민건강보험공단 산정특례 안내

- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 실지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **출처:** 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터 — 사실 확인에 참고한 자료(센터 문장·그림은 실지 않음). 더 자세한 암 정보와 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899(평일 9~18시).
- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.
- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.
- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
- 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.

완전판에는 이런 내용이 더 있습니다

- 0기 결정 질문지(방사선 생략·호르몬약 5년), 0기 보험 청구 주의
- 가상 병리보고서 해설, 영상검사별 목적과 흔한 오해
- 아형별 시나리오 4가지(가상 사례), 항암 시작 전 14일 체크표
- 수술 전후 체크리스트, 배액관 관리, 어깨 운동 시작 시점, 재건 비교
- 항암 주기별 부작용 달력, 탈모·두피냉각, 내분비요법 5~10년 생활 가이드
- 방사선 상담 질문지와 피부 관리

- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법
- 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)
- 림프부종 자가 체크표(팔 둘레 기록), 운동·압박 슬리브, 신체상·관계
- 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)
- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것
- 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트
- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)
- 유방암 용어사전
- 유방암 자주 묻는 질문 13
- 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
- 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크달력

ApuDa.app — 더 많은 암·질환 교육 콘텐츠와 업데이트 Instagram 구독자 무료 배포판 · 상업적 재배포 금지

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>